뇌동맥류 가족력·ADPKD

MRA 선별검사 대상과 추적 상담

아래 선별검사 대상·간격은 박중철 연자의 강의 내용이다. 상염색체우성 다낭신(ADPKD)과 가족력의 강도를 구분해 상담한다.

핵심 판단의 흐름



강의에서 제시한 선별 대상

위험군	조건·수치
ADPKD	뇌동맥류 유병률 약 8–12%(일반인의 4–5배), 평생 위험 10–15%로 제시. 증상 없어도 초기 MRA 시행을 권고했다.
가족력	1촌 가족 중 뇌동맥류·지주막하출혈 병력 2명 이상: 유병률 ≥10%, 20세 이상 또는 가족 발병 나이 기준으로 MRA 권장. 1명 가족력은 일반인 대비 약 3배 위험으로 설명했다.
결합조직질환	교재는 Marfan 증후군·Ehlers–Danlos IV형 등을 고위험군으로 제시했다.

정상 선별검사와 발견 후 추적을 구분

상황	강의·연자 Q&A
ADPKD·정상 MRA	교재는 5년 간격, 구두 설명은 약 4–5년마다 추적 권고. 가족력이 있으면 더 적극적 검진을 강조했다.
뇌동맥류 발견	연자 Q&A: 처음 확인되면 신경외과에서 위험도를 평가. 저위험 추적 권고 뒤에는 정기 영상으로 관찰할 수 있다고 답했다.
기록·급여 설명	연자 Q&A: 가족력 선별검사 이유를 외래기록에 명기하며, 강의의 추적 기간으로 시행할 때 급여로 검사한다고 답했다.

진료실에서 기억할 점

음성 선별검사 후 ADPKD 추적과 이미 발견된 동맥류 추적은 다르다. 발견된 소형 동맥류는 첫 6–12개월, 안정적이면 1–2년 간격으로 제시했다.